



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

**Керівникам структурних
підрозділів з питань охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
обласних державних адміністрацій**

**Керівникам центрів контролю та
профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров'я України**

**Національна служба здоров'я
України**

Щодо локального моніторингу
за антимікробною
резистентністю збудників, які
спричиняють інфікування ран
при пораненнях

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) звертається з наступним.

На виконання Порядку проведення посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричиняють гнійнозапальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій, затвердженого наказом МОЗ України від 27 лютого 2023 року № 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2023 року за № 489/39545 (далі – Порядок) заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу у стаціонарних умовах пацієнтам, які отримали поранення, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України (далі – стаціонар), проводять



№ 04-09/18/629/24 від 07.02.2024
КЕП ВОВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
ЮРІЙОВИЧ
248197DDFAB977E504000003B7A080181F12C04

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-09/18/629/24 від 07.02.2024



№22-742/01-11/1-24 від 07.02.2024

бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з ран, а також крові та ліквору від пацієнтів які отримали поранення, у випадках що передбачені положеннями Порядку. За результатами проведених досліджень бактеріологічні лабораторії, які надають послуги стаціонарам щокварталу надають звіти за визначеною формою до Центру.

За звітній період з 01 жовтня по 31 грудня 2023 року (IV квартал) до Центру надійшли звіти від 302 з 547 стаціонарів, що складає 55,2%. Крім того, надали інформацію 36 установ та їхніх відокремлених підрозділів системи громадського здоров'я МОЗ України. Із загального числа закладів, які прозвітували, 49,7 % надали інформацію про позитивні результати щодо виділення патогенів зі зразків біологічного матеріалу від поранених внаслідок бойових дій та визначення і оцінки чутливості їх до протимікробних препаратів.

За результатами посиленого епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю мікроорганізмів, що спричинюють гнійно-запальні інфекції ран у поранених внаслідок бойових дій зроблено такі висновки:

1) звіти про дослідження зразків з ран, крові, ліквору та споживання АМП відповідно до вимог Порядку надали на 4 стаціонари менше, ніж в III кварталі, що може свідчити про зменшення прихильності до дотримання вимог Порядку.

2) за IV квартал загальна кількість досліджених зразків з ран, крові та ліквору, збільшилась на 13,4 % (з 8 911 до 10 104).

3) кількість досліджених зразків крові збільшилась на 13,9 % (з 469 до 537), відносна частка крові в загальній масі зразків зменшилась з 5,6 % до 5,3 %. Позитивними були 16,8 % зразків.

Кількість досліджених зразків спинномозкової рідини збільшилась на 29,4 % (з 109 до 141 зразків), а відносна частка від загальної кількості зразків змінилась з 1,3 % до 1,4%. Позитивними були 29,8 % досліджених зразків (31,2 % у III кварталі).

Не зважаючи на позитивну динаміку, кількість досліджених зразків крові та ліквору залишається критично низькою, що заважає провести ґрунтовний аналіз резистентності виділених штамів до антимікробних препаратів.

4) за весь період спостереження найбільшу кількість штамів мікроорганізмів було виділено у двох часових груп пацієнтів: при перебуванні в стаціонарі менше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин та при перебуванні в стаціонарі більше 48 годин та при пораненні отриманому більше 72 годин, що може бути пов'язано із зростанням ризику розвитку інфекційних ускладнень при тривалому перебуванні пацієнта в стаціонарі.

5) позитивні за Грамом мікроорганізми зберігають високий рівень чутливості до усіх груп антибіотиків. Рівень MRSA становить 24,5 %.

6) протягом всього періоду спостереження привертає увагу, що культури мікроорганізмів одного виду тестуються до різного набору антибіотиків. Це свідчить про недотримання бактеріологічними лабораторіями рекомендацій

EUCAST щодо аналізу чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів та ускладнює аналіз та інтерпретацію отриманих даних.

7) найбільш поширеним антибактеріальним препаратом залишається цефтріаксон (19,0%) в той час, як резистентність до нього також залишається однією з найбільш високих. Частка цефтріаксону серед призначень зменшилась з 33,7 % в III кварталі до 19,0% в IV кварталі, що є наслідком перенесення даного препарату до групи резерву. Також зменшилось споживання інших препаратів групи цефалоспоринів на 18,0 %.

8) антибактеріальна терапія без своєчасного проведення мікробіологічних досліджень та перегляду або призначення АБП широкого спектру дії з метою профілактики на перших етапах евакуації призводять до пришвидшеної селекції антимікробної резистентності. Це ускладнює подальше лікування таких пацієнтів.

9) спостерігається призначення антибактеріальних препаратів, молекули яких не зареєстровані в Україні, що викликає занепокоєння щодо раціонального та безпечного використання таких препаратів.

10) боротьба з поширенням антимікробної резистентності та раціональне використання антибактеріальних препаратів потребує своєчасного отримання результатів бактеріологічних досліджень та проведення перегляду терапії.

З метою покращення ситуації, що склалася у стаціонарах з рівнем поширення збудників з антимікробною резистентністю рекомендовано:

1) підвищити рівень дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та нормативно-правових актів;

2) сприяти швидшому обстеженню пацієнтів та отриманню результатів бактеріологічних дослідження для перегляду призначень АБП;

3) впровадити методологію визначення чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів EUCAST;

4) забезпечити достатній вибір АБП у стаціонарах та на етапах медичної евакуації;

5) раціоналізувати призначення АБП;

6) посилити обізнаність щодо необхідності проведення бактеріологічного обстеження поранених;

7) забезпечити дотримання стандартних заходів захисту.

Додаток: Аналітична довідка на 30 арк. у 1 прим.

В.о. Генерального директора

Олександр ВОВЧЕНКО

Панасюк Марія
044-334-58-02